

URGENCIAS OTOLÓGICAS: OTALGIA

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

OTALGIA

INTRODUCCIÓN

La otalgia es un síntoma muy frecuente. La innervación sensitiva del oído proviene de los pares craneales V, VII, IX, X y del plexo cervical (C2 y C3).

- Pabellón auricular: innervado por las ramas de los nervios craneales V, VII, X y ramas de los nervios cervicales C2 y C3.
- Conducto auditivo externo: nervios craneales V, VII y X par.
- Membrana timpánica: nervios craneales VII, IX y X par.
- Oído medio: nervios craneales V, VII y IX par.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en su gran mayoría en una exhaustiva historia clínica y a veces se debe de confirmar con exámenes complementarios: analítica sanguínea, audiometría, impedanciometría, tomografía computarizada, resonancia magnética, otras.

La otalgia podemos dividirla en 2 grupos:

- **Otalgia primaria:** Originada en estructuras propias del oído como consecuencia de infecciones, traumatismos, cuerpos extraños, tapones de cerumen impactados, neoplasias otológicas y otros.
- **Otalgia secundaria:** Referida, por patología de estructuras vecinas: alteraciones dentales, disfunción de articulación temporomandibular, neuralgia del trigémino, neoplasias de cabeza y cuello, arteritis de la temporal, síndrome de Eagle.

características	Otalgia primaria	Otalgia secundaria
Dolor	Continuo y en aumento con los días	Intermitente asociado a patología de la ATM y con los movimientos de cavidad oral.
Síntomas	Otorrea, plenitud ótica, disminución de la audición.	fiebre, disfagia, reflujo gastroesofágico, dolor nasosinusales, odontalgias
Tiempo	Evolución corta	evolución larga

Manejo

Una historia clínica completa a veces es todo lo que se requiere para hacer un diagnóstico correcto y es esencial para determinar si la causa es primaria o secundaria.

Tiempo de evolución corto: sugiere una causa primaria o benigna.

Tiempo de evolución largo: sugiere una causa secundaria.

Preguntar presencia de otorrea, pérdida de audición, vértigo, plenitud auditiva y acúfenos. Buscar síntomas asociados con la cavidad oral, historia dental, síntomas orofaríngeos, antecedentes de amigdalitis y patología sinusal.

Exploración física: Inspección general del oído externo, regiones preauricular y postauricular, otoscopia y progresar hasta el examen de los pares craneales para evaluar si hay

complicaciones.

TRATAMIENTO

Dependerá del tipo de otalgia y en función a la clínica que presenta.

ALERTA

- Valoración por ORL si otalgia persistente o inexplicada con exploración normal; asociación de disfonía, disfagia, pérdida de peso; pérdida auditiva; inmunosuprimidos o diabéticos por progresión rápida de enfermedad. Por CMF si los síntomas parecen ser de origen odontogénico.

BIBLIOGRAFÍA

- Cummings C. Cummings otolaryngology head & neck surgery. Philadelphia, Pa: Elsevier Mosby. 2017.
- Poulton S, Yau S, Anderson D, Bennett D. Ear wax management. Aust Fam Physician 2015;44(10):731–34